

COURS PRATIQUES - SÉMIOLOGIE GYNÉCOLOGIQUE

THÈME DU SÉMINAIRE : Anamnèse et examen clinique gynécologique

OBJECTIFS :

- Savoir mener une anamnèse gynécologique complète et inclusive comprenant :
 - L'investigation d'une plainte gynécologique
 - La récolte des antécédents généraux et gynéco-obstétricaux
- Connaître l'anatomie de la région génitale
- Connaître le déroulement d'un examen gynécologique de routine : inspection génitale, examen au spéculum, toucher vaginal, y compris l'exploration d'une plainte spécifique
- Savoir comment effectuer les différents prélèvements au niveau génital

L'examen gynécologique fait partie de la formation d'un-e étudiant-e en médecine. L'objectif de l'enseignement de l'examen physique génital est de permettre à l'étudiant-e de distinguer le physiologique du pathologique. Toutefois, il faut comprendre que l'examen gynécologique touche la sphère intime de la/du patient-e* et est un examen parfois invasif ; il requiert donc un consentement explicite oral, consentement qui doit être renouvelé pour les différentes parties de l'examen (inspection, toucher, spéculum).

Lors de ces entraînements, un examen sur mannequin sera réalisé. Les mannequins sont basés sur un modèle anatomique unique, qui n'est pas représentatif de la variabilité anatomique dans la population. Celui-ci permet l'apprentissage des habiletés procédurales et la familiarisation avec l'examen gynécologique réel ainsi que la reconnaissance de l'anatomie et des repères appropriés et permettent de s'entraîner aux gestes à effectuer pour un examen clinique gynécologique.

*Inclusivité : l'anamnèse gynécologique concerne toutes les personnes avec des organes génitaux internes et / ou externes dits féminins, quel que soit leur identité de genre. Cela inclut donc des femmes cis, des femmes trans, des hommes trans ainsi que des personnes non-binaires (voir lexique si ces notions ne vous sont pas familières).

INTRODUCTION

Comment aborder la sexualité en consultation ? Quelques conseils :

Avant la consultation

- Ayez une attitude réflexive : Avant tout, évaluez votre propre aisance à discuter de sexualité avec divers groupes de patient-e-s et identifiez tout préjugé que vous pourriez avoir. Si vous n'êtes pas à l'aise de parler de sexe et de sexualité, votre patient-e le sera aussi.

Au début de la consultation

- Rappeler le cadre de confidentialité et celui de non-jugement. Pour se faire, signaler ouvertement son attitude non discriminante par une annonce d'inclusivité est une solution. (p.ex : « Ici, on accueille toutes les personnes, quels que soient leurs origines, leurs religions, leurs orientations sexuelles ou affectives ou leurs identités de genre. »)
- Mettez votre patient-e à l'aise en établissant une relation (empathie, respect, ouverture, inclusivité) avant de poser des questions intimes.
- Demandez les pronoms ou la terminologie préférée lorsque vous parlez à un-e patient-e transgenre ou non-binaire. Utilisez ces pronoms et soutenez l'identité de genre actuelle, quelle que soit son anatomie.

-

Avant d'aborder l'anamnèse sexuelle dans l'entretien

- Contextualisez la raison qui vous pousse à aborder la sexualité. Vous pouvez p.ex :
 - Utilisez des déclarations générales pour normaliser les sujets dont vous discutez, cela aide les patient·e·s à comprendre que les préoccupations sexuelles sont courantes. Par exemple : « *À ce moment de la consultation, je pose généralement des questions à propos de votre vie sexuelle.* »
 - Expliquez l'éléments qui motive votre besoin de faire l'anamnèse sexuelle à ce moment. (P.ex : « *Pour savoir quels examens de laboratoire nous devons réaliser aujourd'hui, j'aurais besoin de vous poser quelques questions sur votre vie sexuelle.* »)
- Demandez la permission de manière explicite pour aborder ces sujets (p.ex : *Est-ce que cela serait ok pour vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?*)
- Rappelez la possibilité de ne pas répondre à certaines questions si la personne le souhaite

Pendant l'anamnèse sexuelle

- Utilisez des termes neutres et inclusifs (ex: "partenaire" "personne") et posez vos questions sans porter de jugement de manière professionnelle.
- Évitez de faire des suppositions sur votre patient·e en fonction de son âge, de son apparence, de son état civil, de sa religion, de son origine géographique ou de tout autre facteur. A moins que la personne ne vous le dise, vous ne pouvez supposer de l'orientation sexuelle, des comportements ou de l'identité de genre d'une personne.
- Essayez de ne pas réagir de manière excessive, même si vous vous sentez mal à l'aise. Faites attention à votre langage corporel et à votre posture.
 - Reformulez votre question ou expliquez brièvement pourquoi vous posez une question si un·e patient·e paraît surpris·e ou réticent·e à vous répondre.
 - Assurez-vous que vous et votre patient·e partagez une compréhension des termes utilisés pour éviter toute confusion. Par exemple : Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un·e? Par "relations sexuelles" je comprends le sexe vaginal, anal ou oral. Si vous n'êtes pas familier·ère avec un terme utilisé par votre patient·e, demandez une explication.
- Assurez-vous que les termes utilisés pour désigner les parties du corps ne créent pas de dysphorie pour les patient·e·s transgenres ou non-binaires. Essayez de reprendre le vocabulaire du/de la patient·e.

LEXIQUE

Avortement spontané ou Grossesse arrêtée ou Grossesse non-évolutive	Grossesse s'arrêtant spontanément avant 20 semaines d'aménorrhées Souvent nommée « fausse couche » dans la population générale
Cisgenre	Adjectif qualifiant une personne dont l'identité de genre correspond au genre assigné à la naissance
Consentement explicite	A la différence du consentement présumé, le consentement explicite implique un accord oral clair ou un accord par écrit des personnes impliquées. Le consentement se doit d'être : - Libre : La personne n'est pas contrainte d'accepter (ni sous pression, menace ou insistance). Personne ne l'oblige à dire oui, y compris le/la médecin. - Éclairé : La personne a toutes les informations pour prendre sa décision, notamment les alternatives si elle refuse. - Enthousiaste : La personne exprime un "oui" sincère par ses paroles et/ou langage corporel, sans signes d'ambivalence.
Dyschésie	Gêne ou douleurs à la défécation
Dysménorrhée	Douleurs lors des règles
Dyspareunie	Ce terme regroupe l'ensemble des douleurs dans le vagin ou au niveau de la vulve avant ou après un rapport sexuel. Elle peut être : - Superficielle : Douleurs au niveau de la vulve ou de l'orifice vaginal - Profonde : Douleurs ressenties à l'intérieur lors des rapports sexuels pénétratifs, au niveau du pelvis et au fond du vagin.
Expression de genre	Le genre que l'on montre aux autres (e.g. habillements, maquillage, etc)
Genre	Construction sociale permettant de catégoriser les rôles, comportements, expressions et sentiments identitaires considérés comme féminins, masculins ou ne correspondant à aucune de ces deux catégories
Hématochézie	Présence de sang dans les selles
Identité de genre	Sentiment profond et intime d'appartenance au genre féminin ou masculin (binaire), ni l'un ni l'autre (non-binaire), aucun genre (agenre); parfois l'un ou l'autre (fluidité de genre). Cela ne correspond pas forcément avec son sexe biologique.
Interruption de grossesse	Grossesse arrêtée de manière médicamenteuse ou chirurgicale
Intersexuation	Les personnes intersexes ou intersexuées sont des personnes dont le corps possède des caractéristiques biologiques ne correspondant pas ou qu'en partie aux catégories binaires employées généralement pour distinguer les corps "femelles" des corps "mâles".
Ménarche	Premières menstruations
Mutilation génitale féminine (MGF)	Selon l'OMS, « les mutilations génitales féminines désignent toutes les interventions aboutissant à l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes féminins pour des raisons non médicales. »
Non-binaire	Adjectif qualifiant une personne qui ne se reconnaît pas dans les catégories binaires de femmes et d'hommes.
Orientation sexuelle	Elle désigne l'attraction sexuelle pour les personnes d'un ou plusieurs genres
Prolapsus	Descente d'organes. On distingue :

	- Cystocèle : Descente de la vessie qui appuie contre la paroi antérieure du vagin - Hystérocèle : Descente de l'utérus - Rectocèle : Descente du rectum qui appuie contre la paroi postérieure du vagin La cystocèle  L'hystérocèle  La rectocèle 
Pubarche	Apparition des premiers poils pubiens
Saignements utérins anormaux	Regroupe plusieurs types de saignement, comme les saignements intermenstruels (entre les périodes de règles) ou les règles abondantes <i>Ancienne terminologie : Métrorragies, ménorragies, etc.</i>
Santé sexuelle	Selon l'OMS, la santé sexuelle est un « état de bien-être physique, mental et social à l'égard de la sexualité, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle s'entend comme une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que comme la possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, exemptes de coercition, de discrimination et de violence. Pour que la santé sexuelle soit assurée et protégée, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et appliqués »
Sexe	Attributs biologiques permettant de catégoriser les personnes ou les animaux comme femelle, mâle ou ne correspondant à aucune des deux catégories.
Sexualité	L'OMS décrit la sexualité comme « ... un aspect central de l'être humain tout au long de la vie, qui englobe le sexe, les identités de genre et les rôles y afférents, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction. »
Syndrome prémenstruel	Symptômes physiques et psychologiques dans la semaine qui précède les menstruations et qui se terminent avec celles-ci
Thélarche	Développement des seins
Transgenre trans* ou	Adjectif qualifiant une personne dont l'identité de genre ne correspond pas au genre assigné à la naissance. L'astérisque sert à inclure la variété des transidentités, dont les personnes non-binaires.

1 - ANAMNÈSE : QUESTIONS À POSER PAR LES ÉTUDIANT·E·S

MOTIF DE CONSULTATION : Investiguer la plainte de la/du patient·e* (ex : douleurs pelviennes, saignements anormaux, pertes vaginales, démangeaisons, brûlures...)

- Caractérisation de la douleur
 - Localisation
 - Irradiation
 - Qualité (douleur sourde, en coup de couteau, crampiforme...)
 - Facteurs déclenchants et circonstances d'apparition (à l'effort, au repos, pendant ou après un rapport sexuel, apparition brutale/progressive)
 - Facteurs aggravants/soulageant (effort, mobilisation, rapport sexuel, repos, assis, couché, antalgiques utilisés...)
 - Douleurs nouvelle ou connue
 - Temporalité (durée, caractère cyclique, pendant les menstruations, mi-cycle)
 - Impact fonctionnel (empêche de faire certaines activités, travail/dormir)
- Caractérisation des pertes vaginales et démangeaisons
 - Pertes vaginales anormales (augmentées, aspect : grumeleux, spumeux, liquide, couleur, présence de sang, odeur)
 - Démangeaison (vulvaire, vaginale, périanale)
- Caractérisation des saignements anormaux
 - Temporalité (selon la période du cycle menstruel)
 - Quantité (nombre de protections/jours et fréquence des changements)
 - Durée des cycles et des menstruations
 - Dysménorrhée
- Symptômes associés : État fébrile, frissons, fatigue, adénopathie
- Cycle actuel : Date des dernières règles (DDR)
- Anamnèse urinaire et digestive
 - Troubles urinaires : algurie, dysurie, brûlures (en urinant ou intermittentes/persistantes), pollakiurie, hématurie, urines malodorantes, douleurs lombaires
 - Troubles digestifs : transit (constipation, diarrhée), dernières selles, hématochézie, dyschésies
- Partenaire(s) : Symptômes similaires chez la/le/les partenaire(s)

ANTÉCÉDENTS PERSONNELS

- Antécédents médicaux
 - Pathologies chroniques (par ex HTA, diabète, surpoids, obésité)
 - Hospitalisations antérieures
 - Allergies (substances, type de réaction)
- Antécédents chirurgicaux : Interventions (année, indication, voie d'abord : laparoscopie/laparotomie/voie vaginale/chirurgies ou modifications génitales y compris mutilations génitales, chirurgie d'affirmation)
- Antécédents gynéco-obstétricaux
 - Ménarche, pubarche, thélarche (attention à ne pas investiguer tout le temps, dépend du degré d'urgence et du contexte)
 - Cycle : régulier, durée du cycle et des règles, quantité (nombre de serviettes tampons/jour), dysménorrhée, syndrome prémenstruel
 - Saignements (utérins) anormaux
 - Ménopause (lorsque cela est pertinent) : Symptômes ménopausiques (bouffées de chaleur, prise de poids, irritabilité, sécheresse vaginale, etc.), traitement hormonal substitutif
 - Rapports sexuels : Partenaire régulier/ère, multiple, nombres de partenaires antérieurs, dyspareunie (profonde/superficielle), protection

- Contraception actuelle et antérieure, selon les pratiques sexuelles évoquées
- Gestité : Nombre de grossesse (évolutive, avortement spontané, interruption de grossesse) : *Avez-vous déjà été enceinte ? Combien de fois ?*
- Parité (dès 22 SA) : Année, terme de la grossesse, santé de l'enfant : *Combien de fois avez-vous accouché ?*
 - Basse : Spontané, instrumenté (forceps, ventouse) ou non, présence d'une lésion périnéale simple ou compliquée dans l'immédiat et à long terme
 - Césarienne et son indication
 - Complications néonatales et du post-partum ?
- Antécédents d'IST ou d'affections gynécologiques
- Dernier contrôle gynécologique (dont dernière cytologie (=dépistage du cancer du col), mammographie si pertinent)
- Habitudes
 - Tabac, alcool, substances autres
 - Traitements actuels
 - Activité physiques et alimentation
- Anamnèse familiale
 - Oncologique : Sein, utérus, col, digestif, autres (préciser degré de parenté, âge du diagnostic)
 - Antécédents thromboemboliques (TVP, EP, âge d'apparition)
 - Diabète, maladies cardiovasculaires (dont HTA, AVC et SCA)
 - Autres pathologies chroniques ou héréditaires
- Anamnèse socioprofessionnelle
 - Activité professionnelle
 - Entourage familial
 - Enfants à charge
 - Antécédents de violences¹: physiques, psychologiques, sexuelles et gynécologiques et/ou obstétricales et mutilation génitale (à savoir avant d'effectuer un examen gynécologique) : *“Est-ce que vous avez déjà subi des violences de type psychologiques, physiques, sexuelles dans votre vie?” « Est-ce que dans votre vie vous avez déjà été touché-e de manière où vous n'étiez pas d'accord ? »*
 - Origine de la patiente* (plusieurs conditions ou pathologies gynécologiques sont plus fréquentes dans certains groupes ethniques)

¹ Un dépistage systématique des violences est efficace et utile dans la pratique médicale. Il peut se faire simplement d'une question générale. Il est important pour tout·e soignant·e de savoir informer et orienter vers le réseau de soins compétents, en fonction de la réponse reçue. Cf. pour en savoir plus

2 - EXAMEN CLINIQUE

1. Signes vitaux : TA, pouls, température
2. Poids, taille, BMI
3. Examens complémentaires systématiques : Bandelette urinaire (stix) et test de grossesse

Pour chaque étape de l'examen, un consentement explicite oral doit être (re-)demandé en veillant à ce que le/la patiente* soit bien installé·e.

Lorsqu'il s'agit du premier examen gynécologique, il peut être utile d'expliquer précisément comment il va se dérouler.

Pendant les gestes, décrire progressivement ce que l'on fait et surveiller le visage afin de détecter des douleurs reproduites.

En absence de consentement, ne pas effectuer le geste et proposer des alternatives (auto-prélèvements, que la/le patient.e mette le spéculum elle/lui-même).

/!\ Préparer le matériel avant d'examiner le patient·e pour limiter la durée de l'examen

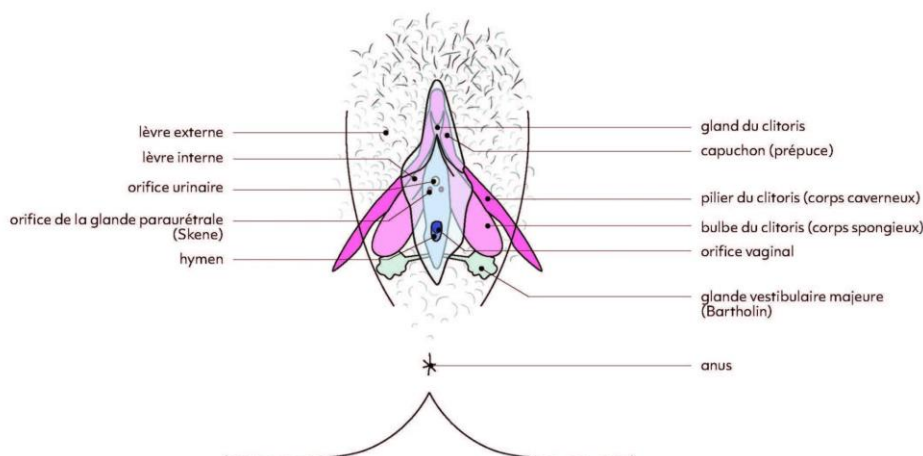
Débuter par un status abdominal (inspection, auscultation, palpation superficielle/ profonde, percussion des loges rénales, palpation des aires ganglionnaires).

INSPECTION GÉNITALE

4. Vulve : Lèvres externes, lèvres interne, prépuce clitoridien, gland du clitoris, entrée du vagin, caroncules hyménéales, présence de MGF
5. Périnée
6. Région péri-anale
7. Mont du pubis
8. Régions inguinales: adénopathies

Rechercher en fonction de l'anamnèse des lésions érythémateuses, vésicules, ulcérations, cicatrices de lésion périnéale ou épisiotomie, furoncle, hémorroïdes, pilosité générale, prolapsus (cystocèle, rectocèle, hystérocèle)

Rappel: Il est important d'être conscient·e qu'il existe une grande diversité dans l'anatomie des vulves. La vulve change au cours de la vie en fonction des changements hormonaux et des antécédents de la/du patient.e*.



EXAMEN AU SPÉCULUM (demander consentement avant le geste →voir lexique)

1. Position gynécologique, les fesses dépassant légèrement le rebord de la table, surélévation légère des fesses
2. Écarter les lèvres internes
3. Introduire le spéculum à 45° avec appui sur la fourchette vaginale postérieure, vis entièrement ouverte et lames du spéculum fermées
4. Ouvrir progressivement le spéculum jusqu'au fond du vagin avec les lames de part et d'autre du col en tournant le spéculum en position horizontale

NB : Si on ne trouve pas le col, il vaut mieux refermer un peu le spéculum et se repositionner que de chercher le col avec le spéculum ouvert. Lorsque le col est difficile à trouver, une palpation vaginale peut aider à situer le col.

5. Fixer la vis ou tourner la fixation (selon le modèle de spéculum)
6. Mise en évidence du col avec inspection :
 - Col nullipare/multipare, lésions, leucorrhées physiologiques ou anormales (couleur, aspect, odeur), inspecter les parois vaginales
7. Effectuer les prélèvements nécessaires en fonction de l'anamnèse [JB1]
 - Examen direct (permet de regarder les sécrétions au microscope lors de la consultation) : prélèvements dans le fornix postérieur mettre sur 2 lames ; dans une goutte de NaCl 0.9%,
 - Cytologie cervicale (frotter l'exocol avec la spatule puis l'endocol avec la brosse)
 - Prélèvements bactériologiques ou PCR pour la recherche de chlamydia et/ou gonocoque
8. Retirer le spéculum : Ouvrir la vis entièrement, sortir en effectuant une rotation afin de visualiser les parois vaginales antérieures et postérieures, fermer progressivement le spéculum, garder le spéculum légèrement ouvert pour ne pas pincer les muqueuses.
/!\ Le sortir à deux mains pour éviter qu'il s'ouvre d'un coup sur l'orifice vaginal.



PALPATION VAGINALE BIMANUELLE (demander consentement avant le geste)

- Insérer l'index lubrifié (et éventuellement le majeur)
- Palper le col (position, taille, consistance, douleurs à la mobilisation, lésion palpable)
- Avec la main abdominale : ramener le contenu pelvien vers les doigts vaginaux, Explorer la face antérieure et la face postérieure de l'utérus (taille, consistance, contours), les régions annexielles (masse, douleurs → On ne devrait rien sentir)
- Avec les doigts insérés dans le vagin : Palper les parois notamment au fond, le cul-de-sac de Douglas (douleurs, masses), latéralement, les ligaments utérosacrés (douleurs) et postérieurement (vers le bas), la paroi vaginorectale.

AU TERME DE LA FORMATION, L'ÉTUDIANT.E DOIT ÊTRE CAPABLE DE :

- Mener une anamnèse gynécologique complète et inclusive.
- Connaître le déroulement de l'examen clinique gynécologique, à savoir :
 - Inspection des organes génitaux externes
 - Recueil du consentement
 - Examen au spéculum
 - Prélèvement vaginal pour analyse microbiologique lors de l'examen au spéculum
 - Prélèvement cervical pour cytologie cervicale lors de l'examen au spéculum
 - Palpation vaginale bimanuelle
- Savoir justifier le déroulement de l'examen gynécologique et connaître les éléments importants pour l'évaluation d'un symptôme (savoir décrire les constatations pouvant être décelées grâce à cet examen).

LECTURES ET VIDÉOS RECOMMANDÉES

1. Lynn S. Bickley. Bates' Guide to Physical Examination and History-Taking. Ninth Edition WB205, Female Genitalia, chapitre 12, pp 429-448
2. Vidéo examen gynécologique - Bates' physical examination videos : <https://batesvisualguide.com/multimedia.aspx?categoryID=21787#21782>
3. Moodle de l'unité Reproduction : <https://moodle.unige.ch/course/view.php?id=3880>
4. «Virtual Skills lab. - Gynécologie & Obstétrique» disponible sur le site : <https://moodle.unil.ch/course/view.php?id=285>

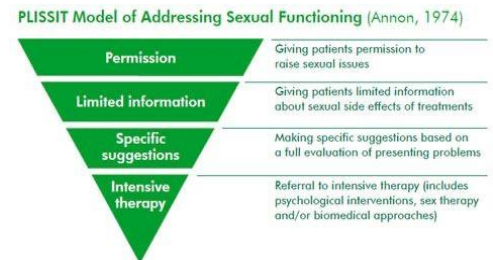
POUR EN SAVOIR PLUS

ANAMNESE SEXUELLE

L'anamnèse sexuelle entre dans le cadre de la consultation gynécologique. Elle entre également dans l'intimité de la personne. Toutes les questions ne sont pas pertinentes à chaque consultation, il faut se poser la question de quelles réponses sont nécessaires pour avancer dans la prise en charge. (cf. texte d'introduction)

Un exemple de modèle d'anamnèse sexuelle : PLISSIT Model of Addressing Sexual Functioning

C'est un modèle proposé pour que tout.e spécialiste puisse débiter une anamnèse sexuelle, en demandant tout d'abord la permission (voir exemples de phrases), donner les informations et suggestions à l'échelle de nos connaissances, puis référer à un.e spécialiste en sexologie ou psychologie si nécessaire.



Exemples de phrases de permission :

- Est-ce que je peux vous poser quelques questions concernant votre sexualité ? Je pose ces questions systématiquement car de la même manière que les autres questions que je vous pose, elles sont importantes pour comprendre votre état de santé générale.
- A ce moment de la consultation, je pose généralement des questions à propos de votre vie sexuelle. Est-ce que cela serait ok pour vous?
- Vous pouvez également préciser :
- Vous pouvez à tout moment me dire si mes questions vous mettent mal à l'aise ou si vous ne souhaitez pas répondre à certaines d'entre elles.

Les "6 P" :

- Partenaires : *Avez-vous actuellement des relations sexuelles avec un.e ou des partenaires?*
- Pratiques: *Quels types de contacts sexuels avez-vous (eu) Quelles parties de votre corps étaient impliquées?*
- Protection: *Avez-vous été dépisté.e pour les IST récemment?*
- Passé (antécédents) d'infection: *Avez-vous déjà été (ou votre/vos partenaire-s) infecté.e par une IST dans le passé?*
- Pregnancy/ Grossesse ou intentions de grossesse (si cela s'applique): *À quel point est-il important pour vous de prévenir une grossesse lors de vos rapports?*
- Plus:
 - Pleasure : *Est-ce que vos rapports sexuels sont agréables ?*
 - Problèmes : *Dysfonctions sexuelles (douleurs, troubles de l'excitation, etc.)*
 - Pride : *Soutien et/ou violences dues à l'orientation sexuelle/identité de genre*

Plus d'informations à ce sujet

1. Sexual Health and Your Patients par la National Coalition for Sexual Health : https://nationalcoalitionforsexualhealth.org/tools/for-healthcare-providers/asset/Provider-Guide_May-2022.pdf
2. A Guide to Taking a Sexual History: <https://www.cdc.gov/std/treatment/sexualhistory.htm>
3. Cours par la Dre Jasmine Abdulcadir : "Santé Sexuelle" dans l'Unité d'Immersion en Communauté (3^{ème} année)

DEPISTAGE DES VIOLENCES

Comment aborder/poser la question des violences ?

1. Introduction généralisante :
« Les violences peuvent avoir des conséquences sur la santé, c'est pourquoi comme médecin j'aborde cette question avec tous/tes mes patient-e-s »
« La violence peut être un problème dans la vie des gens, alors j'aborde ce sujet avec tous/tes mes patient-e-s »
« Je demande à tous/tes mes patient-e-s des renseignements sur leurs proches et leurs familles afin de mieux les comprendre et de pouvoir parler des problèmes relationnels qu'ils ou elles pourraient avoir. »
2. Devant certains symptômes très évocateurs :
« La dernière fois que j'ai vu des marques ou des signes comme les vôtres, la personne avait subi des violences, est-ce votre cas ? » « Souhaitez-vous en parler ? »
3. Questions indirectes :
« Tous les couples sont susceptibles de vivre des conflits. Que se passe-t-il quand vous et votre conjoint-e vous disputez ? Est-ce que les conflits tournent en bagarres ? »
« Comment votre partenaire vous traite-t-il/elle ? »
4. Cadrage par des questions plus spécifiques :
« Vous sentez-vous en sécurité dans votre couple / famille, sur votre lieu de travail ? »
« Avez-vous peur d'un-e ex-partenaire ou collègue, de votre chef-fe... ? Souhaitez-vous en parler ? »

Violences dans le milieu du soin :

Il est important de se rappeler que les patient-e-s peuvent aussi vivre des violences dans le milieu médical. Ces violences peuvent avoir un effet sur la santé puisqu'elles peuvent mener à un retard de consultation et une méfiance face aux professionnel-le-s.

Plus d'informations sur le sujet, le réseau et les procédures :

- <https://www.ge.ch/dossier/prevenir-violences-domestiques>
- <http://ge.ch/stopviolence/>
- <http://www.centrelavi-ge.ch/>
- <https://www.prevention-violence.ch/>
- www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/.../Strategies/strategie_violence.pdf
- Vidéo Anna : <http://stop-violences-femmes.gouv.fr/4- outils-pour-l-animation-sur-les.html>

RÉFÉRENCES

Lexique:

- Définition de l'OMS, 2006a
- Rev Med Suisse 2022 ; 18 : 1518-23
- <https://www.inter-action-suisse.ch/definitions>
- <https://www.unicef.org/fr/protection/mutilations-genitales-feminines> -

Violences:

- DU "Santé Sexuelle pour tous-tes" de Sorbonne Université : Cours sur les types de violences et leur dépistage

Images:

- <https://www.hug.ch/gynecologie/prolapsus-genital-femme>
- <https://www.unige.ch/ssi/ressources/ressources-pedagogiques-ssi/planches-anatomiques/planches-anatomiques-de-la-brochure-hey-you/>
- <https://www.docteurclic.com/encyclopedie/speculum.aspx>
- Mon sexe et moi : Mon corps sous la loupe; Vulva Gallery

Cette mise à jour du cahier d'ECC a été réalisée en 2022 par deux étudiantes de la Faculté de Médecine de Genève, Lorena Mackinnon Lacasa et Julia Barbe, dans le cadre du Diplôme Universitaire "Santé Sexuelle pour tous-tes" de l'Université de la Sorbonne.

Elle a été validée par la responsables de l'ECC de gynécologie, la Docteure Jasmine Abdulcadir, ainsi que par les membres du groupe Médecine, Genre et Équité des HUG et de l'UNIGE.